

- ② 출혈이 심하여 빈혈 소견을 보이는 경우 수액 공급이나 수혈이 필요함을 설명★
- ③ 양성 질환인 경우 올바른 배변 습관 및 식습관 개선이 중요함을 설명
 - 변기에 오래 앉아 있지 말고 섬유소가 많이 들어 있는 음식을 섭취
- ④ 나이가 있거나 담배를 많이 피는 등 위험인자가 있는 경우 대장내시경을 통해서 기질성 질환의 감별이 필요함을 설명
- ⑤ 치료받지 않을 경우 생길 수 있는 재출혈 가능성과 기저 질환 악화에 대해 설명
- ⑥ 국가암검진 프로그램 중 대장암은 만 50세 이상 남녀 대상 매년 분변 잠혈검사를 시행하고, 이상 시 대장내시경검사를 하니 정기 검진 권유

❖ 소아 감별 진단 코멘트

- 아래는 소아에서 연령에 따라 혈변의 주요 감별 질환입니다.
 - ① 신생아기 : 분만 시 임신부 혈액 흡인, 괴사 장염(NEC), 세균성 설사, 중장염전(midgut volvulus) 등
 - ② 영아기 : 항문 열상, 창자꺾침증, 메켈 게실
 - ③ 학령 전기 및 학령기 : 연소 용종, 소화성 궤양
 - ④ 청소년기 : 성인과 비슷, 소화성 궤양, 염증성 장질환
- 이 중에서 중요한 질환은 **연소 용종, 메켈 게실, 중장염전** 정도인 것 같습니다. **응급 질환인 중장 염전의 특징**을 잘 알아둡시다. 중장 염전의 경우 보통 생후 1개월 내 신생아가 갑자기 담즙성 구토, 토혈, 혈변 등을 동반하며, 배가 팽만하다는 것이 특징입니다. 응급 수술이 필요하기에 이에 대해 설명하는 것이 중요합니다. 다만 신생아기 질환이라 CPX에 직접적으로 출제되기에는 어려움이 있을 수 있다고 생각합니다.



keyword

혈변의 발생 위치, 출혈량, 점액변 여부를 물어 기질적 원인을 감별하기
 병력 청취 : 항문 질환 감별하기 위해 덩이/출혈량/변비 등 동반 증상 묻기
 신체 진찰 : **혈압/맥박을 확인해 응급 상황 여부를 가장 먼저 확인할 것, 빈혈/탈수 여부 추가로 확인하기, DRE 등 임상술기 필요 시 함께 진행하기**
 위험 인자 : 고령, 흡연력, 대장암 가족력 → 건강 검진 권장하기
 교육 : 양성 질환의 경우 올바른 배변 습관, 식습관 개선 설명하기, 만 50세 이상 환자의 경우 국가암검진 프로그램 검진 설명, 권유하기
 응급 상황 교육 : **출혈량이 많거나 빈혈 증상을 보일 경우 수액 공급 및 수혈이 필요성 설명하기**

시험 관련 코멘트



구토의 경우 식사와 관계 여부를 확인하기 위해 당시 상황을 묻는 open question으로 시작하는 것이 좋습니다. 또한 구토의 양상(C) character, 즉 양/색/냄새에 대해 자세히 물어보는 것이 중요합니다. 색깔과 동반된 증상을 토대로 구토의 원인을 감별할 수 있습니다.

구토는 크게 소화기계와 신경계로 나누어 생각할 수 있습니다. 뒤에 나오는 어지럼 감별 진단에 해당하는 BPPV, 뇌수막염, 뇌출혈 등을 물어보는 것을 잊는 경우가 많으므로 구토와 어지럼을 연결해서 기억해 두면 좋습니다. 젊은 여성은 임신(임덧)을 따로 감별하는 것이 필요합니다. 신체 진찰을 통해서도 소화기계, 신경계 감별이 도움이 될 수 있음을 기억합니다.

급성 구토와 함께 설사, 복통을 호소하며, 주위 비슷한 증상을 호소하는 사람이 있다면 식중독을 가장 먼저 고려해야 합니다. 식중독이 의심되는 경우 원인이 될만한 음식물에 대해 자세히 문진하고, 식사와 증상 발생 사이의 잠복 시간을 확인하여 원인균을 추정하고 이에 맞는 치료 전략을 세워야 합니다. 환자가 탈수 증상을 보일 경우 수액 치료를 치료받아야 함을 설명하는 것이 좋습니다. 환자가 심한 탈수 증상을 보이거나, 신경계 질환이 의심될 시 입원을 권유합니다.

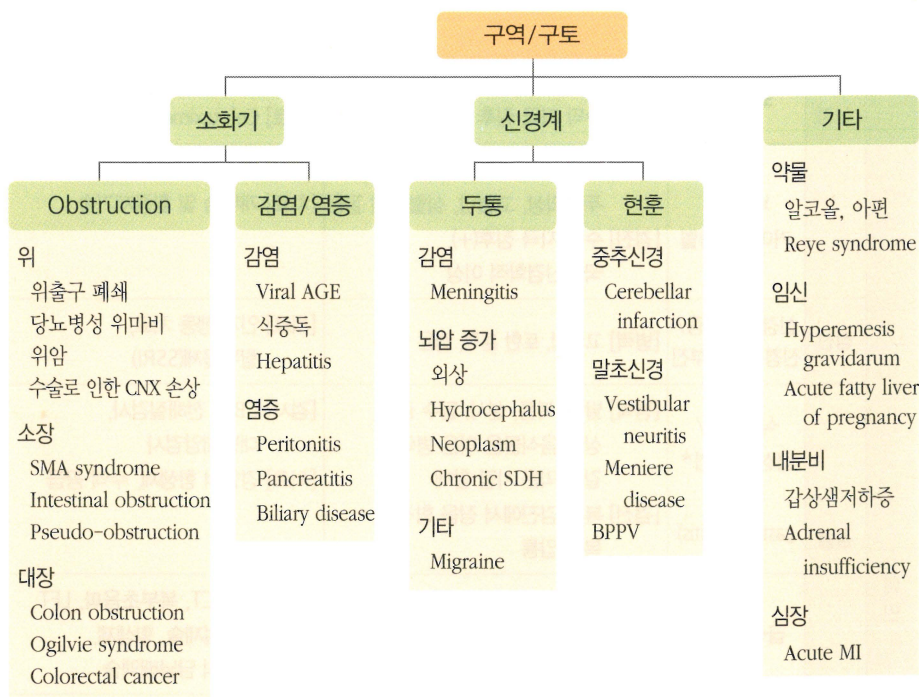
CPX 항목 중 모의 환자분들이 누워서 시작하는 증례가 있는데, 구토도 이 중 하나입니다. 누워 있어 당황할 수 있는데 문 들어가지마자 의자를 끌어서 환자분 눈높이에 맞게 앉고 손 닦으면서 진료 시작하면 됩니다.

구토의 색을 물을 때는 혈성/녹색/하양/ 노랑(비담즙)의 색을 꼼꼼히 묻고, 음식물이 섞여 있는지, 사출성인지도 파악합니다. 장폐색의 여부 감별 위해 수술 및 입원을 반드시 물어야 합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
소아		날문협착증	[병력] 생후 2~3주, 분출성, 담즙 없는 구토, 토하고 자꾸 먹으려 함 [검진] 소아라 감진 못할 듯	[검사] 복부초음파 [치료] 전해질 교정, 날문근절개술
		장중첩증	[병력] 생후 3~12개월, 복통, 복부에서 올리브 종괴 만져짐, 딸기잼 같은 분변 [검진] 소아라 감진 못할 듯	[검사] 복부초음파 [치료] 공기정복술, 바륨정복술, 응급 수술

성인	신경	양성돌발체위 현기증 (BPPV)	[병력] 어지럼증, 메스꺼움 [검진] Dix-Hallpike test(어지럼 참조)	[검사] Dix-Hallpike test [치료] 에플리 수기 (Epley maneuver)
		뇌수막염	[병력] 두통, 발열, 경부 강직 [검진] 수막 자극 징후 양성	[검사] 뇌 CT, 뇌척수액 천자 [치료] Cefotaxime+Vancomycin 등
		뇌출혈/ 거미막밑출혈	[병력] 두통, 의식 저하, 극심한 두통, 두부외상, 고혈압, 심혈관계 질환 [검진] 수막 자극 징후(+), 국소신경학적 이상	[검사] 뇌 CT, 뇌척수액 천자 [치료] 개두술 및 혈중제거술
	정신	신경성 폭식증/ 신경성 식욕부진	[병력] 고의성, 토한 흔적, 젊은 여성	[치료] 인지 행동 치료, 항우울제(SSRI)
	감염	식중독★/ 급성 위장염★ (acute gastroenteritis)	[병력] 발열, 복통, 설사, 탈수 증상, 상한 음식을 먹은 병력, 같이 먹은 사람 함께 [검진] 복부 검진에서 장음 항진, 복부 압통	[검사] CBC, 전해질검사, 대변배양검사 [치료] 경형적 항생제, 수액 공급
		급성 담낭염	[병력] 복통, 소화불량, 식후 악화, 발열 [검진] 복부 검진에서 복통, Murphy's sign	[검사] 복부 CT, 복부초음파, LFT [치료] 담낭절제술, 항생제, 경피적 담낭배액술
	염증 / 폐쇄	위염, 위궤양, 십이지장궤양★	[병력] 속쓰림, 복통, 신물 올라옴, 흑색변(위궤양), 식후 악화 (위궤양)/식전(십이지장) [검진] 복부 검진에서 복통	[검사] 위내시경, 요소날숨검사, 신속요소분해효소검사 [치료] 양성자펌프억제제, 제산제, 위점막보호제
		위암★	[병력] 빈혈 증상, 체중 감소, 흑색변 [검진] 복부 검진에서 복통, 림프절(+)	[검사] 위내시경 [치료] 위절제술, 내시경적 점막하절제술
		장폐색증★ (ileus)	[병력] 식후 복통, 복부 수술 [검진] 복부 검진에서 장음 항진 없음	[검사] 복부 엑스레이 [치료] 코위관 삽입, 전해질 교정, 수술
	임신	임신	[병력] 최근 생리 없음 [검진] 골반 진찰	[검사] urine hCG [치료] 산전 상담
	신장	요독증	[병력] 만성 신부전 병력, 피로, 거품뇨 [검진] 특이 사항 없음	[검사] serum BUN/Cr, 신장초음파, 소변검사 [치료] 신대체요법, 신장 이식



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 구토를 시작하셨나요? 갑자기 시작했나요?/서서히? 어떤 상황에서 구토를 하였나요? → 식사와 관련이 있는지 묻는 것임
L	-
D	구토를 몇 번 정도 하셨나요?
Co	구토를 하는 게 점점 더 심해지시나요?
Ex	이전에도 이런 증상이 있으셨나요?/항구토제나 제산제를 드셨었나요?

C	[정도] 일상 생활에 지장과 많이 불편하셨나요? [양상] 양/음식물이 섞여 나왔나요?/냄새/색깔(담즙, 피 동반?) [암기법] 일지 위에 양은 냄비로 끓인 빨간 라면 [설명] 일지(일상 생활에 지장) 위에 양은냄비(양, 냄새)로 끓인 빨간(색갈, 피 동반) 라면
A	[전신] 발열/오한/식은땀/피로/체중 변화 [탈수] 목마름/호흡곤란/두근거림/소변량 감소가 있나요? [신경계] 어지럼/이명/두통/경부 강직/보행장애/팔다리 힘빠짐이 있었나요? [소화기] 식욕 저하/설사/혈변/흑색변/지방변/ 복통(구토 후 복통 변화, 식전 식후 복통 변화)/속쓰림/연하곤란이 있었나요? [비뇨기] 소변색 변화/거품뇨 [피부] 피부 발진 [신경성 폭식증/신경성 식욕부진] 고의적으로 구토하시나요? 스스로의 체형에 대해 어떻게 생각하시나요? [암기법] 강경했던 형은 아파도 고의로 힘을 빼진 않았다고 보장할 수 있다. [설명] 강경(경부 강직)했던 형은(체형) 아파도(두통) 고의로(고의적 구토) 힘을 빼진(팔 다리 힘 빠짐) 않았다고 보장(보행장애)할 수 있다.
F	[식중독] 어제 드신 음식은 무엇인가요? → 최근에 먹은 음식 종류 묻기 같이 식사하신 분들도 똑같이 구토를 하시나요? 최근에 과식/과음 하셨나요? 최근에 여행을 다녀오셨나요? 스트레스를 많이 받으시나요?
E	이전에 복부 수술 받은 적 있나요?/두부외상이 있었나요?
외	복부 수술을 받으신 적 있나요?/복부를 다친 적 있나요?
과	이전에 진단 받은 병이 있나요? (고혈압/당뇨/간질환/결핵)
약	현재 복용 중인 약물이 있나요? (항구토제)
사	술은 드시나요?/흡연은 하시나요?/직업은 어떻게 되시나요? [식습관] 평소 식습관은 어떠신가요?/맵고 자극적인 음식을 주로 드시나요?
가	가족 중에 혹은 같이 음식을 먹은 사람들도 똑같은 증상을 호소하나요? 가족 중에 소화기 질환을 앓고 계신 분이 있나요?
여	[월경력] LMP/규칙적/주기/생리량/생리통/임신 가능성!

P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막 (빈혈)/공막 (황달) 2. 입 : 혀 (탈수)/일부러 구토한 흔적 (치아, 손등 확인) 3. 목 : 경부 림프절 촉진 4. 피부 : 발진, 피부 긴장도 소화기계 의심 시 [누워서] 5. 복부★ : 시-청-타-촉 신경계 의심 시 [앉아서] 6. 뇌신경검사 (동공 반사, 안구 운동, 얼굴 감각, 얼굴 운동) 7. 팔다리 신경학적 검진 : 운동, 감각, DTR [누워서] 8. 수막 자극 징후
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 정맥주사 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	토하는 것 때문에 많이 힘드셨을 것 같습니다.
추정 진단	김00님의 경우 전날 먹은 음식을 다 토하고, 녹색 담즙이 나온 점, 신체 진찰 상 복부 압통과 반발 압통, 복벽 강직 소견, 그리고 2개월 전에 복부 수술을 받은 것을 종합했을 때 급성 장폐색이 가장 의심이 됩니다.
감별 진단	하지만 구토를 일으키는 원인으로 식중독이나 소화장애 등의 질환을 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 복부 X-ray, 전체혈구검사, 전해질검사 등이 필요합니다. 괜찮으신가요?
치료	정확한 진단이 나오기 전까지는 입원을 하고 금식하시면 증상이 좀 나아질 것입니다. 영상검사와 혈액검사 결과에 따라 수술이 필요할 수도 있는 상황입니다. 이해되셨나요?
예후	아직 정확히 진단된 것은 아니기 때문에 너무 걱정하지 마시기 바랍니다. 지금부터 잘 치료를 받으시면 호전될 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
교육	혹시라도 어지럽거나 목이 몹시 마른다가나 소변량이 줄어드는 경우 탈수 증상이므로 수액 치료가 필요합니다. 이런 증상이 생기면 바로 말씀해 주시기 바랍니다. 앞으로도 식중독 예방을 위해 식사 전에는 항상 손을 씻고, 위험한 음식물은 가려 먹는 것이 좋습니다. 항구토제는 일시적으로 증상을 완화할 뿐이므로 가급적 사용하지 않는 것이 좋습니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, 전해질, ESR, CRP, serum BUN/Cr
- ② 임신반응검사
- ③ 영상검사 : 복부 X-ray, 복부 CT, 상부 위장관내시경, 대장내시경, Brain MRI
- ④ 요소날숨검사

❖ 치료 계획

- ① 경구 수액요법
- ② 소화불량, 속쓰림 : H₂-blocker, Proton pump inhibitor
- ③ 임신 초기 구토 : 아침 음식 섭취량 소량으로, 정서적 지지
- ④ 식중독 : 수액 치료, 금식, 항생제
- ⑤ 장폐쇄 : 코위관으로 감압, 금식, 입원, 수술

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 안심시키기 : 특별한 합병증 없이 치유되는 경우가 대부분
- ② 탈수 증상 시 입원 후 수액 치료를 받고 음식을 하여 치료를 받아야 함에 대해 설명★
- ③ 신경학적 문제로 발생한 응급 상황 시 입원 후 조치가 필요함에 대해서 설명★
- ④ 음식물을 먹기 전에 손을 항상 씻고, 위험한 음식물을 가려 먹으라는 위생 교육
- ⑤ 필요 시 항구토제 사용 가능하지만 가급적 사용하지 않도록 교육
- ⑥ 구토 유발 요인 : 고지방식 피하기, 소화 안 되는 음식 피하기
- ⑦ 항구토제 부작용 : 변비, 설사, 피로, 두통



keyword

소화기계와 신경계 감별하기

젊은 여성은 임신(임덧)을 따로 감별하기

식사와의 관계/구토의 양, 색, 냄새 파악하기

환자 교육 : 탈수 증상을 보일 경우 수액 치료 설명하기

소아 파트 진단/치료 계획도 숙지하기

사형 관점 코멘트



배변 이상은 과거 나뉘어 있던 '변비'와 '설사'가 합쳐진 항목입니다.

감별 진단 목록이 완전 다르기 때문에 환자의 주소를 듣고 나누어 생각해야 합니다. 두 항목 모두 **변의 양상**을 자세히 물어보는 것이 중요합니다. 또한 설사와 변

비 증례에서 **모두 내분비 질환(부신 및 갑상샘 질환)을 감별**하는 것을 잊지 말아야 합니다.

변비의 경우 기질성인지 기능성인지 감별하는 것이 중요합니다.

병력 청취 시 **수분 섭취, 식습관, 운동 여부, 약제 사용력**은 잊기 쉽지만 중요한 항목이니 잊지 마세요. 기질적 원인과 기능성 원인 여부를 감별해 향후 진단검사와 생활 습관 교육 또는 치료를 적절히 안내하는 것이 중요합니다. 중년 여성에서 잔변감, 질쪽으로 밀려나오는 느낌 등 증상을 호소하는 경우 직장류를 의심해야 합니다.

신체 진찰에서 **내분비 질환 중 갑상샘 질환을 감별하기 위해 목 진찰**을 해야 하며, 복부 진찰을 시행해야 합니다.

환자 교육 시 변비약을 장기간 복용하면 배변 반사신경이 둔화되므로 변비가 더 악화됨을 교육하는 것이 중요합니다.

변비의 경우 임상 술기로 항문 직장 진찰이 포함돼 있습니다.

설사의 경우 급성(2주 이내)과 만성(4주 이상)에 따라 의심해야 하는 질환이 달라집니다. 급성 설사의 경우 감염성과 비감염성 원인을 감별해야 하며, 만성 설사의 경우 기능성과 기질적(염증성 설사 등) 원인을 감별해야 합니다. 설사와 관련된 수분, 전해질 이상에 대한 치료 계획을 수립할 수 있는지를 평가합니다.

병력 청취 시 급성 설사의 경우 며칠 전 날 것 섭취 등 식습관을 확인해 식중독을 의심해 볼 수 있습니다.

신체 진찰 시 설사, 구토와 같이 체액이 소실되거나 어지럼, 실신 등 체액 부족 증상이 나타날 수 있는 모듈의 경우 **혀, 피부긴장도 등을 관찰해 탈수 정도를 평가**해야 합니다.

환자 교육 시 혈변, 심한 체중 감소가 동반되는 경우 기질적 원인을 의심해 대장내시경의 필요성을 설명하고, **설사량이 많은 경우 탈수로 인한 응급 상황이 생길 수 있음을 교육하는 것이 중요합니다**. 또한 **전해질 이상 여부도 의심 시 추가로 검사를 의뢰해야 합니다**. 또한 감염성 설사의 경우 치료로 항생제가 필요할 수 있다는 것과 **지사제의 남용을 자제하는 것을 꼭 언급**해주는 것이 좋습니다.